CONTROL DEL DOLOR EN NIÑ@ NO COMUNICANTE - Revisada (NCCPC-R)

NOMBRE:_____ **UNIDAD / ARCHIVO #:** _____ **FECHA:** _____ **(dd / mm.yy)**

OBSERVADOR:_____ **HORA DE INICIO:** _____ **AM / PM** **TIEMPO DE PARADA:** _____ **AM / PM**

¿Con qué frecuencia ha mostrado este niñ@ estos comportamientos en las últimas 2 horas? Por favor circule el número para cada elemento. Si un artículo no se aplica a este niñ@ (por ejemplo, este niñ@ no come alimentos sólidos o no puede alcanzar con sus manos), a continuación, indica "no aplicable" para ese elemento.

0 = NADA 1 = UN POCO 2 = BASTANTE AMENUDO 3 =MUY FRECUENTE NA = NO APLICABLE

I. Vocal

1. Gimiendo, , lloriqueando (bastante suave)	0	1	2	3	N/A
2. llanto (moderadamente fuerte)	0	1	2	3	N/A
3. Gritando (muy fuerte)	0	1	2	3	N/A
4. Un sonido específico o una palabra para el dolor (por ejemplo, una palabra, grito o el tipo de risa)	0	1	2	3	N/A

II. Social

5. No cooperar, malhumorad@, irritable, infeliz	0	1	2	3	N/A
6. Menos interacción con otros, más retirad@.	0	1	2	3	N/A
7. .Buscando la comodidad o la cercanía física	0	1	2	3	N/A
8. Es difícil de distraer, no es capaz de satisfacerse o apaciguarse	0	1	2	3	N/A

III. Facial

9. Ceño fruncido	0	1	2	3	N/A
10. Cambio en los ojos, incluyendo: cerrar los ojos de forma momentánea, apertura, los ojos con el ceño fruncido.	0	1	2	3	N/A
11. Bajando de la boca, sin sonreír.	0	1	2	3	N/A
12. Labios apretados, haciendo pucheros o temblando.	0	1	2	3	N/A
13. Apretar o rechinar los dientes, masticar o empujar la lengua hacia fuera.	0	1	2	3	N/A

IV. Actividad

14. No se está moviendo, menos activ@, tranquil@.	0	1	2	3	N/A
15. Saltando, agitad@, inquiet@	0	1	2	3	N/A

V. Cuerpo y las extremidades

16. Flexible.	0	1	2	3	N/A
17. Rigid@ ,espástic@, tenso.	0	1	2	3	N/A
18. Haciendo un gesto o en contacto con una parte del cuerpo que duele	0	1	2	3	N/A
19. Proteger, favorecer o guardando parte del cuerpo que duele.	0	1	2	3	N/A
20. Que retroceden o se mueve, al contacto con la parte distal que duele.	0	1	2	3	N/A
21. Mover el cuerpo de una manera específica para mostrar el dolor (i cabeze hacia atrás , los brazos hacia abajo, se queja, etc.)	0	1	2	3	N/A

VI. Fisiológico

22. Temblando.	0	1	2	3	N/A
23. Cambiar de color, palidez.	0	1	2	3	N/A
24. Sudoración.	0	1	2	3	N/A
25. Lagrimas.	0	1	2	3	N/A
26. Inhalación brusca, jadeante	0	1	2	3	N/A
27. Contención de la respiración.	0	1	2	3	N/A

VII. Comer / Dormir

28. Comer menos, no está interesad@ en los alimentos.	0	1	2	3	N/A
29. Aumento de sueño.	0	1	2	3	N/A
30. Disminución en el sueño.	0	1	2	3	N/A

S NÚCLEO S RESUMEN:

Categoría:	I	II	III	IV	V	VI	VII	TOTAL
Puntuación:								

Versión 01.2004 © 2004 Lynn Breau, Patrick McGrath, Allen Finley, Carol Camfield

USO DE LA NCCPC-R

El NCCPC-R fue diseñado para ser utilizado por niñ@s, de 3 a 18 años, que no pueden hablar debido a alteraciones cognitivas (mentales / intelectuales) o discapacidades. Puede ser usado si un niño tiene impedimentos físicos o discapacidades. Las descripciones de los tipos de los niñ@s utilizados para validar el NCCPC-R se pueden encontrar en: Breau, L.M., McGrath, P.J., Camfield, C.S. & Finley, G.A. (2002). Psychometric Properties of the Non-communicating Children's Pain ChecklistRevised. Pain, 99, 349-357

El NCCPC-R fue diseñado para ser utilizado sin la formación de los padres y cuidadores (cuidadores). También puede ser utilizado por otros adultos que no están familiarizados con un niño específico. El NCCPC-R puede ser copiado libremente para uso clínico, o su uso en la investigación financiada por agencias sin fines de lucro. Para fines de lucro agencias deben ponerse en contacto con Lynn Breau: Dolor Pediátrico de Investigación, Centro de Salud IWK, 5850 University Avenue, Halifax, Nueva Escocia Canadá, B3J 3G9 (lbreau@ns.sympatico.ca).

El NCCPC-R fue diseñado para ser utilizado para el dolor a corto o largo plazo en el hogar del niñ@ o en un entorno residencial a largo plazo. Si se sospecha el dolor después de la cirugía, o el dolor debido a los procedimientos llevados a cabo en el hospital son la razón para medir el dolor, debería ser usada la versión *Non-communicating Children's Pain Checklist – Postoperative Version*. Se puede obtener contactando Lynn Breau. La información relativa a la NCCPC-PV se puede encontrar en: Breau, L.M., Finley, G.A., McGrath, P.J. & Camfield, C.S. (2002). Validation of the Non-Communicating Children's Pain Checklist - Postoperative Version. Anesthesiology, 96 (3), 528-535

ADMINISTRACIÓN:

Para completar el NCCPC-R, la base de sus observaciones sobre el comportamiento del niñ@ durante la última dos horas. No es necesario observar al niñ@ de forma continua durante este período. Sin embargo, se recomienda que el observador esté en la presencia del niñ@ para la mayor parte de este tiempo (por ejemplo, estar en la misma habitación con el niñ@). Aunque los períodos de observación más cortos pueden ser utilizados, pueden no aplicarse los puntos de corte descritos a continuación.

Los elementos de la subescala / Dormir Comer no pueden ocurrir durante la observación de dos horas. En este caso, la calificación debe basarse en el comportamiento del niñ@ sobre el día de la observación.

En todas las otras subescalas: Al final del tiempo de observación, indique con qué frecuencia se ve o se oye cada elemento. Esto no debe basarse en el comportamiento típico del niñ@ o en relación con lo que él o ella realiza normalmente. Una guía para decidir la frecuencia de los artículos es el siguiente:

0	=	No presente en absoluto durante el período de observación. (Tenga en cuenta si el artículo no está presente porque el niñ@ no es capaz de realizar ese acto, debe ser anotado como "NA")
1	=	Visto o escuchado pocas veces (casi nada), pero que está presente.
2	=	Visto o escuchado varias veces, pero no es continua (no todo el tiempo).
3	=	Visto o escuchado a menudo, casi continua (casi todo el tiempo); alguien se daría cuenta fácilmente esto si vieron al niño por unos momentos durante el tiempo de observación
N / A	=	No aplica. Este niño no es capaz de realizar esta acción.

TANTEO:

1. Sumar las puntuaciones de cada subescala y anotarlos en la puntuación del resumen en la parte inferior de la hoja. Los elementos marcados "ND" se marcó como "0" (cero).
2. Sume todas las puntuaciones de la subescala en la puntuación total.
3. Compruebe si la puntuación del niñ@ es mayor que el punto de corte.

PUNTOS DE CORTE:

Basándose en las puntuaciones de los 71 niños de 3 a 18 años (Breau, McGrath, Camfield y Finley, 2002), una puntuación total de 7 o más Indica un niñ@ tiene dolor. Esto era preciso para el 84% del el grupo de estudio. Una puntuación total de 6 o menos indica un niño no tiene dolor. Este dato fue correcto en el 77% del grupo de estudio.

USO DE LAS PUNTUACIONES DE CORTE:

Al igual que con todas las herramientas para el dolor de observación, se debe tener cuidado en el uso de puntos de corte, ya que no puede ser fiable al 100%. No deben usarse como la única base para decidir si un niño debe ser tratado para el dolor. En algunos casos, los niños pueden tener puntuaciones más bajas cuando el dolor está presente. Para obtener instrucciones más detalladas para el uso de la NCCPC-R en este tipo de situaciones, consulte el manual completo, disponible en Lynn Breau: Pediatric Pain Research, IWK Health Centre, 5850 University Avenue, Halifax, Nova Scotia Canada, B3J 3G9 (lbreau@ns.sympatico.ca).